



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN HAK PASIEN DAN KELUARGA

RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**TOR Pelatihan Hak Pasien dan Keluarga
RS Prima Husada Malang
Tahun 2025**

I. Latar Belakang

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sejahtera, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. Selanjutnya dalam Pasal 46 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kesehatan dengan pendekatan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, merupakan penyesuaian dari SKN 2004, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009, dinyatakan bahwa salah satu subsistem dari SKN adalah subsistem upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan salah satu unsur dalam subsistem upaya kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Pelayanan Kesehatan meliputi peningkatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan tradisional dan komplementer melalui Pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan dan efektivitas yang tinggi. Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia lanjut usia, dan keluarga miskin.

Pasien dan keluarganya adalah pribadi yang unik dengan alat, sifat, sikap, perilaku yang berbeda-beda, kebutuhan pribadi, agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi. Rumah Sakit membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan pasien untuk memahami dan melindungi nilai budaya, psikososial, serta nilai spiritual setiap pasien.

Hasil pelayanan pada pasien akan meningkat bila pasien dan keluarga yang tepat atau mereka yang berhak mengambil keputusan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pelayanan dan proses yang sesuai dengan harapan, nilai, serta budaya. Untuk mengoptimalkan hak pasien dalam pemberian pelayanan yang berfokus pada pasien dimulai dengan menetapkan hak tersebut, kemudian melakukan edukasi pada pasien serta staf tentang hak dan kewajiban tersebut. Para pasien diberi informasi tentang hak dan kewajiban mereka dan bagaimana harus bersikap. Para staf dididik untuk mengerti dan menghormati kepercayaan, nilai – nilai pasien, dan memberikan pelayanan dengan penuh perhatian serta hormat guna menjaga martabat dan nilai diri pasien.



II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit

III. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan Umum
Terciptanya proses asuhan dilaksanakan di rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, konvensi internasional, dan perjanjian atau persetujuan tentang hak asasi manusia yang di sahkan oleh pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatkan kulaitas pelayanan medis dengan memberikan informasi medis yang selektif, terpercaya dan menyeluruh kepada setiap pasien dan keluarganya yang datang ke rumah sakit.
 - b. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pasien maupun keluarganya seperti rencana promotive, diagnostic, rencana terapi, prognosis, rencana rehabilitative dan rencana preventif.
 - c. Menyempurnakan system kerja Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Prima Husada demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
 - d. Mensukseskan program pemerintah dalam bidang kesehatan dan promosi kesehatan khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan system kesehatan nasional.

II. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

1. Susunan Panitia

NO	JABATAN	PIC	URAIAN TUGAS
1	Ketua Pelaksana	Fadhila Ayu Setyani, S.Kep.,Ns	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Sejak persiapan hingga akhir Memastikan acara berjalan sesuai rencana
2	Sekretaris	1. Mahesa Yudistiranti, S.AP 2. Amlilatul Kholifah, A.Md.Kep	Bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : Laporan kegiatan UMANDOK
3	MC	Alifia Dian Sukma, S.Kep.,Ns	Bertanggung jawab terhadap susunan acara selama berjalannya pelatihan
4	Sie Perlengkapan	Erik Ardianata	Bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan alat-alat yang belum tersedia saat acara.
5	IT dan Dokumentasi	1. Malik Victoria, S.Kom 2. Ramadhian Anshari, S.Kom	Bertanggung jawab mempersiapkan LCD, mic, dan laptop, serta sebagai fotografer. Sound (ME) Hasil akhir: foto di LPJ.
6	Sie Fasilitator	Sekretaris RSPH (MONEV : SDM, PKRS RM)	Bertanggung jawab terhadap MONEV : Absen, evaluasi pre-post, teori, evaluasi praktek, dan penilaian. Hasil akhir: rekap hasil monev, E-Sertifikat Monev Paska diklat / penerapan di lapangan (supervise RM), Pengarsipan ke file Diklat dan File kepegawaian Memastikan peserta bisa mengikuti diklat
7	Narasumber	1. Murwani Suryaning S, S.Kep.,Ns (HPK Nakes) 2. Ria Indriani (HPK Penunjang) 3. Fadhila Ayu S, S.Kep.,Ns (HPK Umum)	Mengarahkan media metode diklat Menyiapkan Materi diklat



a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Diklat Hak Pasien dan Keluarga RS Prima Husada Malang Tahun 2025 akan dibagi menjadi beberapa sesi, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	HARI / TANGGAL	WAKTU	JUMLAH PESERTA
1	Staf Umum	Rabu, 16 Juli 2025	Gelombang 1 : 08.00-10.00 WIB	60
			Gelombang 2 : 12.00-14.00 WIB	60
2	Staf Penunjang	Rabu, 16 Juli 2025	Gelombang 1 : 08.00-10.00 WIB	46
			Gelombang 2 : 12.00-14.00 WIB	46
3	Perawat, Bidan & Fisioterapi	Kamis, 17 Juli 2025	Gelombang 1 : 08.00-10.00 WIB	85
			Gelombang 2 : 12.00-14.00 WIB	85

b. Rencana Rapat Panitia

Recna arapat panitia untuk pelaksanaan Diklat HPK RS prima Husada Tahun 2025 akan dilaksanakan pada :

1. Hari, Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
2. Pukul : 10.00-12.00 WIB
3. Materi : Membahas persiapan bahas materi, tupoksi
4. Tempat : Ruang Manajemen Lantai 5

c. Rundown Kegiatan

NO	JAM	DURASI	MATERI	PETUGAS
Gelombang 1				
1	08.00-08.10 WIB	10 menit	Absensi dan Pretest	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi
2	08.10-08.20 WIB	20 menit	Penyampaian materi 1. Hak dan Kewajiban Pasien 2. Second Opinion 3. Permintaan Rohaniawan 4. Handle Complain 5. Transfer Pasien 6. Penerimaan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap 7. Informed Consent 8. Penjagaan Privasi Pasien 9. Penyimpanan Barang Pasien	1. Murwani Suryaning S, S.Kep.,Ns (HPK Nakes) 2. Ria Indriani (HPK Penunjang) 3. Fadhila Ayu S, S.Kep.,Ns (HPK Umum)
3	08.20-09.05 WIB	45 menit	Simulasi dan Roleplay dengan alur : 1. Role play pendaftaran pasien rawat inap, sasaran : staf pendaftaran 2. Roleplay transfer pasien, sasaran : staf umum, perawat, bidan, penunjang 3. Roleplay penerimaan pasien rawat inap, sasaran : staf perawat dan bidan 4. Roleplay handle complain, sasaran : staf umum, perawat, bidan, fisioeterapi, dan penunjang 5. Roleplay informed consent tindakan khusus, sasaran : perawat, bidan, fisioterapi	1. Murwani Suryaning S, S.Kep.,Ns (HPK Nakes) 2. Ria Indriani (HPK Penunjang) 3. Fadhila Ayu S, S.Kep.,Ns (HPK Umum)
4	09.05-09.15 WIB	10 menit	Post test & penutup	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi
Gelombang 2				
1	14.15-14.25 WIB	10 menit	Absensi dan Pretest	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi
2	14.25-14.45 WIB	20 menit	Penyampaian materi 1. Hak dan Kewajiban Pasien 2. Second Opinion 3. Permintaan Rohaniawan	1. Murwani Suryaning S, S.Kep.,Ns (HPK Nakes) 2. Ria Indriani (HPK Penunjang)



			4. Handle Complain 5. Transfer Pasien 6. Penerimaan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap 7. Informed Consent 8. Penjagaan Privasi Pasien Penyimpanan Barang Pasien	3. Fadhila Ayu S, S.Kep.,Ns (HPK Umum)
3	14.45-15.20 WIB	45 menit	Simulasi dan Roleplay dengan alur : 1. Role play pendaftaran pasien rawat inap, sasaran : staf pendaftaran 2. Roleplay transfer pasien, sasaran : staf umum, perawat, bidan, penunjang 3. Roleplay penerimaan pasien rawat inap, sasaran : staf perawat dan bidan 4. Roleplay handle complain, sasaran : staf umum, perawat, bidan, fisioeterapi, dan penunjang Roleplay informed consent tindakan khusus, sasaran : perawat, bidan, fisioterapi	1. Murwani Suryaning S, S.Kep.,Ns (HPK Nakes) 2. Ria Indriani (HPK Penunjang) 3. Fadhila Ayu S, S.Kep.,Ns (HPK Umum)
4	15.20-15.30 WIB	10 menit	Post test & penutup	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi

II. Materi Pembelajaran

NO	ACARA	WAKTU	MATERI	NARASUMBER / PIC
1	Absensi, Pembukaan & Pre Test	10 menit	10 pertanyaan ada 3 versi bank soal dan untuk masing-masing kelompok berbeda soalnya terkait dengan materi	Ketua Pelaksana Sie Registrasi, Pre Test dan Post Test
2	Penyampaian Materi untuk Paramedis, Non Paramedis, dan Umum	10-20 menit	1. Hak dan kewajiban pasien 2. Second Opinion 3. Permintaan Rohaniawan 4. Handle complain 5. Tranfer pasien 6. Penerimaan pasien rawat jalan dan rawat inap. 7. Informed consent 8. Penjagaan privasi pasien. Penyimpanan barang pasien.	Murwani Suryaning S, S.Kep.,Ns (HPK Nakes) Ria Indriani (HPK Penunjang) Fadhila Ayu S, S.Kep.,Ns (HPK Umum)
3	Simulasi dan roleplay	45 menit	1) Role play → Pendaftaran pasien rawat inap (penunjang pdf) 2) Role play → Transfer pasien (umum, nakes, penunjang) 3) Role play → Penerimaan pasien rawat inap (nakes)	Panitia

			4) Role play → Handle complain (umum, nakes, penunjang) Role play → Informed consent tindakan khusus. (nakes)	
4	Post Test Penutupan	10 menit	Pertanyaan sama dengan Pretest dengan nomor acak	Ketua Pelaksana Sie Fasilitator

III. Sasaran atau Peserta

Peserta pelatihan terdiri dari :

No	Profesi / Unit	Jumlah Staf
1	Farmasi	42
2	Radiologi	7
3	Laboratorium	10
4	Pendaftaran	18
5	RM	9
6	PIPP	4
7	Gizi	6
8	Perawat IRNA	74
9	Perawat IRJA	27
10	IKO	12
11	ICU HCU	12
12	Neonatologi	8
13	Maternitas	12
14	IGD	25
15	Manajemen	12
16	IPSRs	6
17	IT SIMRS	3
18	CS	45
19	Driver	5
20	Parkir	12
21	Kasir	10
22	Asuransi Center	10
23	Gudang Umum	1
23	Security	12
TOTAL STAF		369

IV. Media dan Metode

1. Media yang dibutuhkan dalam diklat adalah sebagai berikut :

NO	DAFTAR MEDIA	JUMLAH KEBUTUHAN (PCS)
1	Sound system	1
2	Laptop	1
3	LCD	1
4	Mic	1
5	Waktu untuk menghitung game	Di tayangkan

b. Metode

1. Presentasi materi
2. Tanya jawab
3. Praktik/ Role play

V. Kebutuhan Anggaran

Anggaran dana kegiatan pelatihan :

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KEGIATAN	KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA	SUMBER DANA
1	5 Juni 2025	Diklat Hak Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Malang	Fee Pemateri	3 Orang	Rp.0,-	Kebutuhan akreditasi
			Konsumsi Pemateri dan Panitia	9 Orang	Rp.180.000,-	Dapur RS Prima Husada
			Air Mineral Gelas	385 Pcs	Rp.385.000,-	
TOTAL BIAYA					Rp.545.000,-	PT DPM

VI. Monitoring Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring pada saat persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan serta aplikasi di lapangan. Pada saat perencanaan dilakukan rapat koordinasi Bersama membahas tentang persiapan kegiatan kemudian dilanjutkan pelaksanaan kegiatan.

2. Target dan Indikator Keberhasilan

Pelatihan dapat berjalan dengan sesuai rundown, peserta hadir 70% dan penyampaian dapat tersampaikan dengan maksimal yang dapat diketahui dari hasil post test yang mencapai poin rata-rata diatas 80.

3. Evaluasi

- Evaluasi saat Diklat : dapat dilakukan evaluasi pre dan post test yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta pelatihan selama menjalani kegiatan pelatihan.
- Monitoring dan evaluasi pada saat aplikasi di lapangan yang dapat berupa evaluasi keberhasilan diklat melalui sebuah survei sederhana.

4. Pelaporan

Selanjutnya dilakukan pembuatan laporan yang terkait hasil pelatihan untuk dilaporkan ke Surveyor internal dan selanjutnya ke Direktur RS Prima Husada dan oleh Direktur dilaporkan ke PT Disa Prima Medika.



VII. PENUTUP

Demikian proposal “Pelatihan Hak Pasien dan Keluarga” ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempersiapkan mutu SDM yang lebih berkualitas dan profesional. Untuk itu dukungan semua panitia dan pihak terkait sangat penting dalam keberhasilan acara tersebut.

Malang, 19 Juni 2025

Surveyor Internal Bab HPK

Ketua Pelaksana

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb

Ns. Fadhila Ayu Setyani, S.Kep

Menyetujui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah